

EXAMENS OSTÉO-ARTICULAIRES

Lors du dépistage ostéo-articulaire, il faut toujours faire enlever le pantalon et les chaussettes au patient.



Un grand merci à Antoine Bruge, Léo Fumaux et Raphaël Jenelten pour leur participation!

GALS

QUESTIONS

Have you any pain or stiffness in your muscles, joints, or back?

Est-ce que vous avez une douleur ou une raideur au niveau des muscles, des articulations ou de votre dos?

La douleur et la raideur sont très communs dans le cas de maladies ostéo-articulaires.

Can you dress yourself completely without any difficulty?

Est-ce que vous arrivez à vous habiller et déshabiller complètement sans difficulté?

S'habiller est un test sensible

Can you walk up and down stairs without any difficulty?

Est-ce que vous arrivez à monter et descendre les escaliers sans difficulté?

EXAMEN CLINIQUE

L'examineur demande au patient au patient de marcher en ligne droite, se retourner et revenir en arrière.

L'examineur observe si:

- la marche est harmonieuse, (mouvement symétrique et souple).
- le tronc est droit.
- le mouvement des bras est conservé.



L'examineur observe la l'hauteur:

- des épaules.
- des pointes des omoplates .
- des crêtes iliaques.



Dos

L'examineur demande au patient de dévêtir la partie supérieur de son corps.

L'examineur observe les mouvement et inspecte le dos.

L'examineur observe la symétrie de rectangles parallèles délimités par le thorax, l'abdomen, le bras et l'avant bras.

Chez une personne saine, les deux rectangle sont symétriques



L'examineur observe:

- le creux poplité à la recherche d'asymétrie.
- un valgus ou un varus de la jambe, c'est-à-dire des mollets qui partent vers l'intérieur ou l'extérieur.
- l'arrière du pied et recherche un valgus ou un varus.
- si la face interne de la cheville dépasse de côté.

De côté

L'examineur demande au patient de se placer de côté.

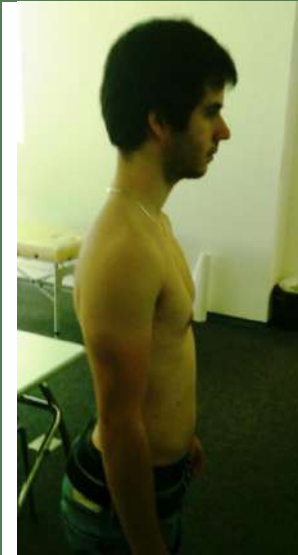
L'examineur examine la lordose cervicale.



L'examineur examine la cyphose thoracique.



L'examineur examine la lordose dorsale.



L'examineur examine la cyphose des fesses.



L'examineur observe l'angle (de l'articulation) du genou. Il recherche un flexum du genou (blocage transitoire ou permanent du genou en position plus ou moins fléchie) un "régionatum" (hyperextension du genou). L'hypertension provoque que le tibia soit en arrière par rapport au quadriceps. Elle est fréquente chez les femmes.



L'examineur observe:

- les avant-pieds
- la cheville

Test de Schober (test de souplesse du rachis):

L'examineur observe le flexion en du tronc.

(Il demande au patient de se tenir droit).

L'examineur identifie la vertèbre située sur la ligne imaginaire reliant les crêtes iliaques au milieu de laquelle (c'est-à-dire sur le rachis) il positionne son index (S1). Il descend son index d'une vertèbre et le maintient à cette position. il place son pouce 10 cm au-dessus de son index.

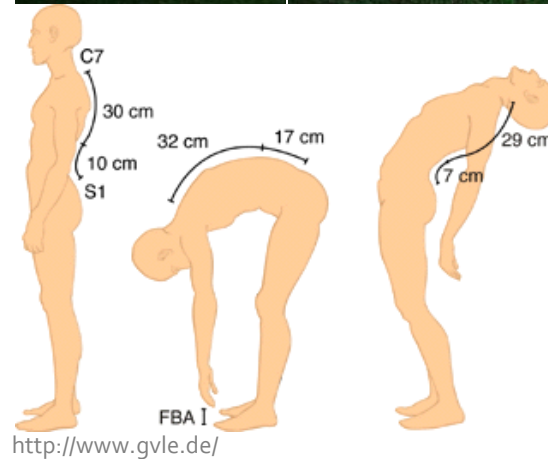
L'examineur demande au patient de se pencher en avant, bras tendus en avant.

L'examineur quantifie la distance index-pouce en position fléchie. Chez une personne saine, la distance doit augmenter au minimum de 5cm.



L'examineur évalue également la distance doigt (du patient)-sol. La valeur normale est de 0 à 10 cm.

Cet test examine la mobilité du rachis et de la hanche ainsi que l'extension des muscles en arrière de la cuisse.



Face

<http://spondyankylosante.blogspot.ch/>

L'examineur demande au patient de se placer de face.

L'examineur observe:

- la symétrie du thorax et de l'abdomen.
- la symétrie des genoux à la recherche d'un épanchement.
- la mobilité du rachis cervical. Pour cela, l'examineur demande au patient de pencher sa tête de côté.

L'examineur recherche des anomalies:

- des avant-pieds.
- des coudes.
- des reins.
- des articulation temporo-mandibulaire. Pour cela, l'examineur demande au patient de déplacer la mandibule de côté.



Dépistage des pathologies de l'épaule:

L'examineur demande au patient de placer ses mains derrière la nuque.

Ce mouvement nécessite de pouvoir réaliser une extension, une abduction et une rotation externe du bras. Il est possible uniquement si l'intégrité des articulation gléno-humorale, des tendons de la coiffe des rotateurs et de la musculature est conservée et si le système nerveux fonctionne correctement.



L'examineur observe la paume des mains et recherche des déformations ou de masses.



L'examineur recherche le manque d'un muscle ou une atrophie.



Mains

L'examineur observe le dos des mains et recherche des déformations ou de masses.



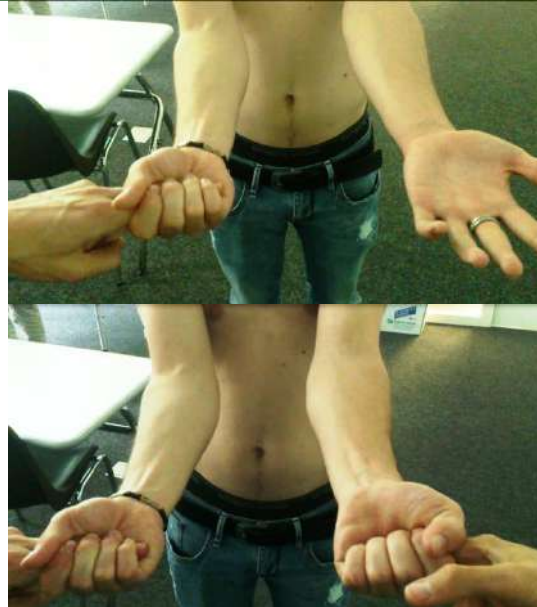
L'examineur évalue la capacité musculaire. Il recherche des lésions articulaires métatarso-phalangienne, interphalangiennes et tendons des fléchisseurs.

Il demande au patient de fléchir les mains.



L'examineur place deux doigts sur la paume de la main du patient et demande au patient de serrer, de fléchir les doigts.

L'examineur évalue la force appliquée et évalue si elle est symétrique.



L'examineur réalise un test de précision, un test neurologique. Il évalue la coordination centrale et regarde si les nerfs périphériques sont intacts.

L'examineur demande au patient de toucher ses doigts avec son pouce.



L'examineur réalise la manœuvre de l'étreinte en analysant les os métacarpo-phalangiennes.

L'examineur serre la main latéralement et demande au patient s'il a mal.



Hanche (même procédé pour l'autre jambe)

L'examineur demande au patient de se coucher (décubitus dorsal).

L'examineur évalue la flexion de la hanche et de du genou.

Il saisit la jambe et la cuisse du patient et les fléchit simultanément.

La cuisse doit être à angle droit par rapport au tronc. La jambe doit être à angle droit par rapport à la cuisse.



L'examineur évalue la rotation du genou et de la hanche.

L'examineur effectue une rotation de la hanche à l'extérieure.



L'examineur évalue la rotation du genou et de la hanche.

L'examineur effectue une rotation de la hanche à l'intérieur.



Test de la distance talon-fesse:

Dans le cas d'une maladie du genou, la personne ne pourra pas rapprocher son talon vers les fesses.

L'examineur rapproche le talon du patient contre ses fesse et évalue la distance.



Test du Glaçon (cf. status de la hanche et du genou)

Le test du glaçon permet d'identifier un épanchement.

1) L'examineur ramène l'œdème vers la rotule en poussant avec les mains vers le genou.



2) Il palpe le centre de la rotule.



Pieds (même procédé pour l'autre jambe)

L'examineur recherche un pied plat.



L'examineur détermine les points d'appui.



L'examineur serre les pieds latéralement et demande au patient s'il ressent une douleur.



A/ STATUS	Réalisé	Partiellement	Non-réalisé
L'étudiant a :			
1. Observé la marche du patient	☐		☐
2. Observé la statique rachidienne dans le plan frontal	☐		☐
3. Observé le patient à la recherche d'un kyste poplité ou d'anomalies des défauts d'axes de l'arrière-pied Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
4. Observé la statique rachidienne dans le plan sagittal et demandé au patient de se pencher en avant en essayant d'aller toucher ses pieds sans plier les genoux Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
5. Observé les inclinaisons latérales de la nuque	☐		☐
6. Demandé au patient de mettre les mains derrière la tête et de mettre les coudes bien en arrière Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
7. Demandé au patient de tendre les bras, paumes vers le haut et observé l'aspect des mains Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
8. Demandé au patient de tourner la main pour évaluer la pro-supination et observé la face dorsale des mains Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
9. Demandé au patient de faire le poing et exécuté une manœuvre d'étreinte (Gänslén) au niveau des deux mains Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
10. Examiné les membres inférieurs pour des défauts d'axes, une amyotrophie ou d'autres anomalies >1 défaut recherché cité = réalisé, 1 défaut recherché cité = partiellement réalisé	☐	☐	☐
11. Testé la mobilité en flexion/extension des deux genoux Si incomplet = partiellement réalisé	☐	☐	☐
12. Examiné les rotations internes et externes des deux hanches Si incomplet = partiellement réalisé	☐	☐	☐
13. Examiné la voûte plantaire des pieds pour une anomalie et réalisé une manœuvre d'étreinte au niveau des têtes métatarsiennes Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
14. Procédé au status de manière systématique = dans l'ordre indiqué	☐		☐